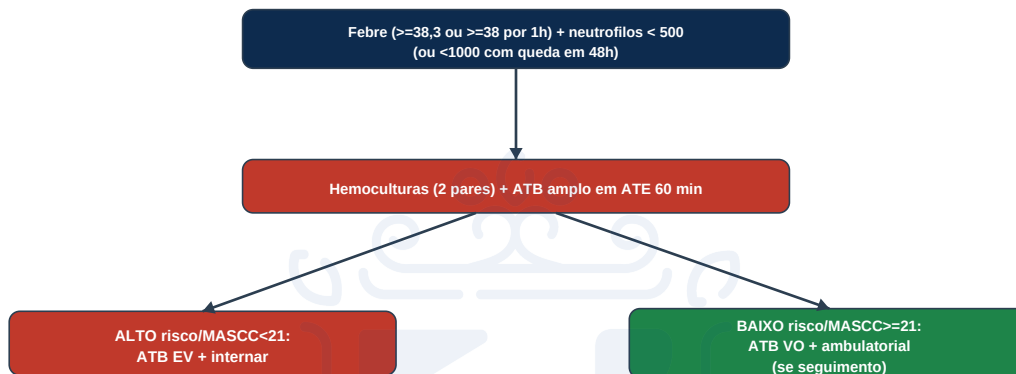


NEUTROPENIA FEBRIL — ATB EM ATÉ 1h

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA

NEUTROPENIA FEBRIL — CULTURA + ATB < 60 min



DEFINIÇÃO

EMERGÊNCIA MÉDICA E ONCOLÓGICA

- FEBRE: temperatura oral $\geq 38,3$ C em uma medida OU ≥ 38 C por 1 hora
- NEUTROPENIA: < 500 neutrófilos/mm³ OU < 1000 com previsão de queda em 48h
- Contexto: QT citotóxica, pós-TMO, imunossupressores; até 50% sem foco identificado
- Em neutropênicos os sinais inflamatórios podem estar AUSENTES — febre é, muitas vezes, o único sinal

AVALIAÇÃO INICIAL

EXAME DIRIGIDO

- Sinais vitais completos + estado mental
- Exame físico dirigido: pele, CATETERES, períneo (NÃO fazer toque retal), cavidade oral, pulmões
- Questionar a DATA da última quimioterapia
- Manifestações possíveis: febre isolada, calafrios, hipotensão, rebaixamento, taquipneia, dor localizada
- Exames obrigatórios (não atrasam o ATB): hemograma, função renal/hepática, eletrólitos, LACTATO, PCR, urina I, RX tórax se sintomas

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

ALTO risco (qualquer um)	BAIXO risco (todos)
Neutropenia esperada > 7 dias; neutrófilos < 100	Estável hemodinamicamente
Instabilidade / sepse / choque	Neutropenia prevista <= 7 dias
Insuficiência renal ou hepática; pneumonia	Sem comorbidades graves
Dor abdominal intensa/diarreia; rebaixamento	Função renal e hepática preservadas
QT intensiva recente; MASCC < 21	Sem foco grave; MASCC >= 21

TRATAMENTO — ANTIBIÓTICO EM ATÉ 60 MIN

Rx POR RISCO

Hemoculturas (2 pares, 1 do cateter se houver) + urocultura ANTES do ATB — sem atrasar
BAIXO risco (VO/ambulatorial): Ciprofloxacino 500mg VO 12/12h + Amoxicilina-clavulanato 875/125mg VO 12/12h (7-14 dias)
ALTO risco (EV, monoterapia): Cefepime 2g 8/8h OU Piperacilina-tazobactam 4,5g 6/6h OU Meropenem 1g 8/8h OU Imipenem 500mg 6/6h
Associar VANCOMICINA (15-20 mg/kg) se: suspeita de infecção de cateter, pneumonia, lesão cutânea grave, hipotensão/choque, colonização por MRSA, hemocultura Gram+
Suporte: hidratação EV, dipirona 1g 6/6h, O2 se necessário, monitorização contínua se alto risco

RED FLAGS

NÃO ATRASAR / NÃO SUBESTIMAR

- ATB amplo espectro em ATÉ 60 minutos da chegada — cada hora de atraso aumenta a mortalidade
- Sinais inflamatórios ausentes não excluem infecção grave
- Hipotensão/choque -> ressuscitação + vancomicina + UTI
- Não fazer toque retal nem usar supositórios (risco de bacteremia/lesão de mucosa)
- Evitar atraso por exames de imagem ou coleta de culturas

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ ALTA: baixo risco (MASCC >= 21) + possibilidade de seguimento ambulatorial garantido + ATB VO
- ☐ INTERNAR: alto risco, necessidade de ATB EV, impossibilidade de seguimento, diagnóstico oncológico em investigação
- ☐ Reavaliar resposta em 48-72h; ajustar conforme culturas
- ☐ Persistência de febre -> ampliar espectro / considerar antifúngico (com hematologia/onco)
- ☐ Orientar sinais de alarme e retorno

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente oncológico com neutropenia febril (neutrófilos ____, febre ____); última QT há ____.
- Risco: alto/baixo (MASCC ____); estabilidade ____; foco: ____.
- Culturas coletadas + ATB iniciado às ____ (____); vancomicina: sim/não.
- Solicito internação (UTI se choque) + monitorização e antibioticoterapia EV de amplo espectro.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente em quimioterapia há 10 dias, febre 38,5 C e neutrófilos 300/mm³. Qual a conduta prioritária?

- A) Aguardar o resultado das hemoculturas antes do antibiótico
- B) Coletar culturas e iniciar antibiótico de amplo espectro em até 60 minutos
- C) Antitérmico e reavaliação em 24h
- D) Iniciar fator estimulador de colônias isoladamente
- E) Transfundir plaquetas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Como se define febre na neutropenia febril?

- A) Temperatura axilar > 37 C
- B) Temperatura oral $\geq 38,3$ C em uma medida ou ≥ 38 C por 1 hora
- C) Apenas calafrios sem febre aferida
- D) Temperatura > 40 C obrigatoriamente
- E) Febre por mais de 5 dias

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual situação indica associar VANCOMICINA ao esquema empírico da neutropenia febril de alto risco?

- A) Febre isolada sem outros achados
- B) Suspeita de infecção de cateter, pneumonia, hipotensão/choque ou colonização por MRSA
- C) Neutrófilos de 400/mm³
- D) Paciente estável de baixo risco
- E) Ausência de foco infeccioso

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com neutropenia febril, estável, MASCC ≥ 21 , neutropenia prevista ≤ 7 dias e bom suporte ambulatorial. Conduta possível?

- A) Sempre internação em UTI
- B) Baixo risco: antibiótico oral (cipro + amoxi-clav) com seguimento ambulatorial
- C) Apenas observação sem antibiótico
- D) Vancomicina endovenosa domiciliar
- E) Antifúngico empírico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que não se deve atrasar o antibiótico na neutropenia febril?

- A) Porque o paciente está sempre estável
- B) Porque o atraso aumenta a mortalidade (risco de sepse fulminante); a janela é < 60 min
- C) Porque a febre é sempre viral
- D) Porque a cultura é desnecessária
- E) Porque os neutrófilos normalizam rápido

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Neutropenia febril é emergência: coletam-se hemoculturas (sem atrasar) e inicia-se antibiótico de amplo espectro em ATÉ 60 minutos. Não se aguarda cultura; G-CSF isolado e antitérmico não substituem o ATB precoce.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Febre = temperatura oral $\geq 38,3$ C em uma medida única OU ≥ 38 C mantida por 1 hora, associada a neutropenia (< 500 , ou < 1000 com queda esperada em 48h).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Associa-se vancomicina se houver suspeita de infecção de cateter, pneumonia, lesão cutânea grave, hipotensão/choque, colonização por MRSA ou hemocultura com Gram-positivo. Não se usa vanco de rotina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Paciente de baixo risco (MASCC ≥ 21 , estável, neutropenia curta, função preservada, bom suporte) pode receber antibiótico oral (ciprofloxacino + amoxicilina-clavulanato) com seguimento ambulatorial.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O atraso do antibiótico aumenta a mortalidade pelo risco de sepse de evolução rápida no neutropênico; por isso a meta é iniciar o ATB de amplo espectro em menos de 60 minutos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico